



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 23, 2026

FRAA → BLOQUEO DE FOLATO CEREBRAL → FOLINATO A ALTA DOSIS COMO INTERVENCIÓN PROMETEDORA

—

Refs:

PMID: 38392599

PMID: 38248763

PMID: 34834493

PMID: 32892962

Lo que está correcto

- **El "19 veces"** es exacto: la meta-análisis de Rossignol & Frye (2021) reporta un odds ratio de 19.03 para anticuerpos antirreceptor de folato alfa (FRAA) en niños con TEA vs. controles típicos sin hermano autista
- **La prevalencia ~76%:** Frye (2020) cita FRAA en 58–76% de niños con TEA . El estudio de bajo funcionamiento concreto sí encontró 76%.
- **Mejora ~65-67%:** la meta-análisis reporta mejora en síntomas generales del 67% en TEA con deficiencia cerebral de folato tratados con leucovorin
- **Dosis ~2 mg/kg:** el ECA de Frye (Mol Psychiatry 2018) usó exactamente 2 mg/kg/día (máx. 50 mg)

- **Sangre normal / LCR bajo:** correcto, es la característica del síndrome de deficiencia cerebral de folato (CFD); hay correlación inversa significativa entre titulaciones de FRAA y 5-MTHF en LCR
- **Folinato penetra vía transportadores alternativos:** el folinato (forma reducida) cruza la barrera por el transportador de folato reducido (RFC), de baja afinidad pero no bloqueado por los FRAA, requiriendo concentraciones suprafisiológicas

Lo que está exagerado o mal

- **"76% tienen EN REALIDAD un trastorno autoinmune":** falso como inferencia. Los FRAA están presentes también en ~38-45% de hermanos típicos de autistas y en un 10-15% de niños sanos sin relación . Es un **subgrupo/subfenotipo** dentro del TEA, no "el autismo es en realidad un trastorno autoinmune". La causalidad aún no está demostrada — puede ser asociación o epifenómeno.
- **"Las pruebas estándar son inútiles":** matizable. El folato sérico es inútil para detectar CFD específicamente, pero no es que toda analítica sea inútil; la prueba de FRAA sérica existe (FRAT), aunque es comercial y su utilidad clínica está debatida.
- **"Suplementos comunes ineficaces":** parcialmente. Ácido fólico sí es inadecuado; el metilfolato comparte parcialmente el receptor $FR\alpha$, por eso se prefiere folinato. Pero "ineficaces" categórico es fuerte.
- **"Médicos líderes usando 2 mg/kg":** la dosis del ensayo clínico es real, pero decir "extremadamente altas" sin contexto de seguridad omite que el perfil es generalmente benigno.

Matices

- El ECA doble ciego positivo fue pequeño (n=48) ; el EFFET francés dio resultados más modestos.
- Es terapia **off-label, no aprobada** para TEA; UCLA lo describe como preliminar, con estudios que no replican
- Hay conflicto de interés estructural: Rossignol/Frye lideran el campo y la prueba FRAT es propietaria (FRATnow), algo que un lector de tu blog apreciaría que se transparentara.

Veredicto: el núcleo biológico (FRAA → bloqueo de folato cerebral → folinato a alta dosis como intervención prometedora) es **real y publicado**, con PMIDs correctos. El framing "el autismo es en realidad autoinmune" es **sensacionalista**: describe un subgrupo tratable plausible, no una redefinición del TEA. Como hipótesis de biomarcador-respuesta (precisión

medicine en TEA), es sólido y de hecho conecta bien con líneas como DEPD/SIGMA-T si lo quieres contextualizar

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

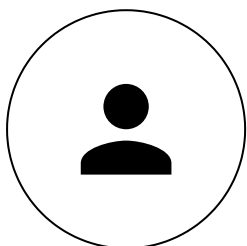
Compartir Publicar un comentario



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de Google Traductor de Goo